RESOLUCION EXTA. Nº 6210
TEMUCO, 12 OCT. 2018

VISTOS; estos antecedentes:
1.- Resolución Exenta Nº6168 de fecha 28.10.2015 que aprueba: *"Norma para la Prevención de Endometritis Puerperal, Tercera Versión"*, del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco;
2.- Documento: *"Norma para la Prevención de Endometritis Puerperal, Cuarta Versión, octubre 2018"*, del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco;
2.- Solicitud de EU Encargada de Depto. de Calidad y Seguridad del Paciente solicitando dejar sin efecto Resolución Exenta Nº6168 de fecha 28.10.2015 y aprobar documento: *"Norma para la Prevención de Endometritis Puerperal, Cuarta Versión, octubre 2018"*, del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco; ,;

CONSIDERANDO:
1.- Que, el artículo 23 del D.S. Nº 38/05, que fija el Reglamento Orgánico de los Establecimientos de Salud de Menor Complejidad y de los Establecimientos de Autogestión en Red, señala que corresponderá al Director las funciones de dirección, organización y administración del Establecimiento Autogestionado;
2.- Que, de acuerdo con lo establecido en la letra c) del artículo 23 del indicado Reglamento, el Director tiene especialmente –entre otras atribuciones- la de organizar internamente el Establecimiento Autogestionado y asignar las tareas correspondientes, conforme a la Ley, al citado Reglamento y acorde a las políticas y normas técnicas que el Ministerio de Salud imparta al respecto;
3.- Que, para dar cumplimiento a los requisitos de forma solicitados por el instrumento de Acreditación de Prestadores Institucionales, es necesario, dejar sin efecto Resolución Exenta Nº6168 de fecha 28.10.2015, y, aprobar mediante resolución exenta de la Dirección del Hospital, el documento: *"Norma para la Prevención de Endometritis Puerperal, Cuarta Versión, octubre 2018"*.

TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en:
1.- D.F.L. Nº 1/05 del Ministerio de Salud, que fija-entre otros-el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. Nº 2763/79 que crea los Servicios de Salud;
2.- El D.S. Nº 140/04, del Ministerio de Salud, que reglamenta los Servicios de Salud;
3.- El D.F.L. Nº 1/19.414/97, del Ministerio de Salud, que separa los Servicios de Salud en Araucanía Norte y Araucanía Sur;
4.- La Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
5.- El D.S. Nº 38/05, del Ministerio de Salud, que fija el Reglamento Orgánico de los Establecimientos de Salud de Menor Complejidad y de los Establecimientos de Autogestión en Red;
6.- El D.S. Nº 03/06, del referido Ministerio, que modifica el citado D.S. Nº 38/05;
7.- La Resol. Exta. Nº 369/08.03.06, que otorga la Calidad de Establecimiento de Autogestión en Red al Hospital Regional de Temuco, Dr. Hernán Henríquez Aravena;

8.- Resolución Exenta Nº01 de fecha 03.01.2018 de la Dirección de Servicio de Salud Araucanía Sur, que establece Orden de Subrogación del cargo de Director del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, de Temuco, a contar del 01.01.2018;
9.-La Resolución Nº 1.600/08, de la Contraloría General de la República, dicto la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

1.- DÉJASE SIN EFECTO Resolución Exenta Nº6168 de fecha 28.10.2015, que aprobó documento: *"Norma para la Prevención de Endometritis Puerperal, Tercera Versión"*, del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco.

2.- APRUÉBASE documento: ***"Norma para la Prevención de Endometritis Puerperal, Cuarta Versión, octubre 2018",*** del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco.

3.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución a Jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia, del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco, remitiéndole copia íntegra de la misma y del referido documento.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
DIRECTOR
TEMUCO

HEBER RICKENBERG TORREJÓN
DIRECTOR SUBROGANTE
HOSPITAL DR. HERNÁN HENRÍQUEZ A.

HRT/TGC/VJV
Distribución
* Dirección H.H.H.A.
* SDM
* SDGC
* C. R. De la Mujer
* Servicio de Ginecología y Obstetricia
* Pabellón Gineco-obstétrico
* Unidad IAAS
* Depto. de Calidad y Seguridad del Paciente
* U. Asesoría Jurídica.
* Of. Partes-Archivo

Norma para la prevención de endometritis puerperal

Elaborado por:	Visado por:	Aprobado por:
Dr. Pedro Lorca Osorio Médico Jefe Unidad de IAAS		
Dra. Helen Stegmaier Bravo Médico Unidad de IAAS	Dr. Juan Ferrada Velásquez Médico Jefe Unidad de ARO	Sr. Heber Rickenberg Torrejón Director (S)

SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ
DIRECTOR
TEMUCO

Elaboradores versiones anteriores del documento:

Versión	Fecha elaboración	Elaboradores
02	Enero 2013	Pedro Lorca Osorio, Médico Jefe Unidad de IAAS. Helen Stegmaier Bravo, Médico Unidad de IAAS.
03	Octubre 2015	Pedro Lorca Osorio, Médico Jefe Unidad de IAAS. Helen Stegmaier Bravo, Médico Unidad de IAAS.

Índice

1. Objetivo. 4
2. Alcance. 4
3. Responsables. 4
4. Documentación de Referencia. 4
5. Definiciones o Glosario. 5
6. Desarrollo 5
   a) Recomendación 5
   b) Evaluación 6
7. Distribución. 6
8. Registro 7
9. Control de Cambio. 7
10. Anexos: 7

1. Objetivo.

Aplicar medidas efectivas para la prevención de infección bacteriana durante los procedimientos de atención obstétrica en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena.

2. Alcance.

Este documento es válido para todo el personal que tiene relación con la atención obstétrica en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena.

3. Responsables.

- Los Médicos que atienden partos y realizan cesáreas, Matronas, Técnicos Paramédicos, Otros profesionales, Auxiliares de servicio, Alumnos de pre y postgrado deben conocer la norma y cumplirla.
- Matronas Supervisoras de Obstetricia y Ginecología, Urgencia Obstétrica, Pabellones Obstétricos y Jefes de Obstetricia y Ginecología y Pabellón deben supervisar y cautelar su cumplimiento además de asegurar la capacitación al respecto.
- UIAAS es responsable de actualización periódica de la norma y su difusión.
- El Departamento de Calidad y Seguridad es responsable de conocer la norma.
- La Dirección del Establecimiento es responsable de conocer y aprobar la presente normativa.
- La Subdirección Médica del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena es responsable de conocer la presente normativa y colaborar en el cumplimiento especialmente en el estamento médico.
- La Subdirección Administrativa es responsable de realizar las gestiones necesarias en su ámbito de competencia para garantizar el cumplimiento a la normativa.

4. Documentación de Referencia.

- Manual de Procedimientos MINSAL 1990.
- Manual de Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias MINSAL 1993.
- Normas de Procedimientos Invasivos para la Prevención y Control de I.I.H., MINSAL, 1989.
- Obstetricia y Ginecología, Dr. Ricardo Celis, Editorial Universidad de la Frontera.
- Infecciones en Ginecología y Obstetricia, Dr. Sergio Silva, Editorial Mediterráneo, 1997.
- Normas de Prevención de Endometritis. Ministerio de Salud. Chile. 2006.

- Surveillance of nosocomial infections in french maternity units Infect Control Hosp Epidemiol 2008; 29:487– 495.
- Norma de Técnica Aséptica vigente en el establecimiento.
- Norma de Profilaxis Antimicrobiana vigente en el establecimiento.
- Norma de Vigilancia IAAS vigente en el establecimiento.
- Resolución de Indicadores de IAAS y su definición.

5. Definiciones o Glosario.

- **UIAAS:** Unidad de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud.
- **ENDOMETRITIS**: Es el proceso infeccioso bacteriano, originado a nivel del lecho placentario, evidenciable en el post - parto o post- aborto. Para efectos de notificación de endometritis como IAAS, se utilizan los criterios definidos en la normativa sobre vigilancia.

6. Desarrollo

a) Recomendación

- Las normas y técnicas para la prevención deben ser aplicadas en todas las unidades de la atención: Urgencia Obstétrica, Pre-parto, Parto, Pabellón y Puerperio.
- La atención del parto debe realizarse con técnica aséptica que incluye:
  - lavado de manos quirúrgico del operador.
  - uso de guantes estériles.
  - uso de material estéril.
  - uso de campos estériles que impidan el contacto del material estéril con superficies no estériles.
- Los tactos vaginales que se realizan durante la atención del trabajo de parto deben realizarse previo lavado de manos del operador y con uso de guantes estériles.
- Los responsables de realizar el procedimiento, pueden ser profesionales, médicos y matronas entrenadas y alumnos o internos en formación debidamente supervisados.
- El número de tactos vaginales debe limitarse al mínimo necesario, idealmente no mayor a 4, excepto en situaciones justificadas.
- Se debe consignar en la ficha clínica del paciente cada uno de los tactos, quien lo realizó y la causa por la que fue indicado. Si se realiza más de un tacto por actividad docente por ejemplo se debe consignar cada uno.

- El personal que realiza la atención del pre parto, parto o puerperio, incluido los tactos vaginales, debe tener la piel de las manos sin heridas y/o infecciones y no debe estar cursando infecciones respiratorias (resfríos, amigdalitis, faringitis, bronquitis, etc).
- Las pacientes sometidas a cesárea deben recibir profilaxis antimicrobiana de acuerdo al esquema definido en el establecimiento (Profilaxis Antimicrobiana descrita en norma de prevención de infección de herida operatoria).
- Durante el puerperio debe realizarse aseo genital según técnica cada 6 horas. Descrito en Manual de Enfermería del adulto.
- El Tacto vaginal debe realizarse con:
    - Aseo genital externo con agua tibia.
    - Higiene de manos previo y posterior al tacto.
    - Uso de guantes estériles.
    - Entreabrir labios mayores y menores.
    - Realizar tacto vaginal.

b) Evaluación

- La evaluación del cumplimiento de la norma se realizará a través de la vigilancia de las tasas de Endometritis asociadas a parto vaginal y cesárea por la UIAAS y socializado a los involucrados.

7. Distribución.

Formato impreso, documento controlado por el departamento de calidad y seguridad del paciente en carpeta de acreditación.

- Servicio de Medicina Materno Fetal y Ginecología.

Formato digital a través de correo electrónico:

- Dirección.
- Subdirección Médica.
- Subdirección Administrativa.
- Subdirección de Gestión del Cuidado.
- CCRR de la Mujer.
- Pabellón de Obstetricia.
- Unidad de IAAS.

8. Registro.

- Registros de tactos vaginales en la ficha clínica.
- Registro de Profilaxis Antimicrobiana en la ficha clínica.

9. Control de Cambio.

DOCUMENTO MODIFICADO		
N° Versión	**Fecha Elaboración**	**Motivo de la Revisión**
02	Enero 2013	Se especifica responsable de realizar del tacto vaginal.
03	Octubre 2015	Se modifica vigencia del documento y se especifica el número de tactos vaginales y el registro de cada uno en ficha clínica.

10. Anexos:

- No Aplica